

美国医药调研及 JPM 大会后反馈

姓名	电话	邮箱	登记编号
余文心(分析师)	021-38676666	yuwenxin@gtht.com	S0880525040111
余克清(分析师)	010-56760093	yukeqing@gtht.com	S0880525120002
陈铭(分析师)	021-23219164	chenming7@gtht.com	S0880525100004
廖博闻(研究助理)	021-23187268	liaobowen@gtht.com	S0880125042239

本报告导读:

本篇报告为我们在美国医药调研及 JPM 大会后的系统反馈，包括对行业及主要治疗领域的最新研判。

投资要点:

- 宏观与产业环境: 政策落地+并购回暖, 创新药风险偏好明显修复。随着政策端不确定性阶段性落地、重磅临床数据持续释放以及全球 M&A 回暖, 2025 年四季度美股生物科技与制药板块显著走强, 投资人对 2026 年创新药投资情绪明显改善。JPM 大会前后两周, MNCBD 交易高度活跃, 中国创新药资产在交易中的占比与能级同步提升, 显示其在全球创新体系中的吸引力持续增强。
- 肿瘤: PD-1/VEGF 双抗确定性持续抬升, Pan-RAS 进入兑现窗口。肿瘤领域中, PD-1/VEGF 双抗已从“机制验证”迈入“临床与产业共振”阶段, 多家 MNC 在 NSCLC 等高价值适应症同步推进多项全球 III 期试验, 年内审批与数据读出有望成为核心催化。与此同时, Pan-RAS 精准治疗围绕胰腺癌与 NSCLC 系统推进一线/二线及联合方案, 关键 III 期数据预计于 2026 年读出, 标志着该方向正进入实质性兑现期。
- 减重代谢: 关注自费市场扩容, 小核酸推动治疗范式升级。在美国肥胖适应症保险覆盖受限、自付额高企的背景下, 自费 (cash-pay) 人群正成为 GLP-1 市场扩容的重要来源, 药企通过直销平台、定价调整与多渠道分发积极提升可及性, 释放需求弹性。小核酸减重方向更多体现为中期升级变量, 其与 GLP-1 联用在减重质量与脂肪分布改善上的潜力, 或推动减重治疗由“单一激素驱动”向“多通路调控”演进。
- 自免: MNC 大单品集中度风险凸显, 2026 年 POC 数据读出带来结构性机会。MNC 自免业务对少数重磅单品依赖度较高, 专利周期与竞争加剧背景下的收入集中风险逐步显现。增量机会主要来自两条路径: 其一, 新一代抗体平台 (双抗/多抗、B 细胞耗竭等) 将在 2026 年迎来密集 POC 数据读出, 或催生新一轮 BD 与资产重估; 其二, 口服化趋势逐步清晰, 自免疾病长期用药属性决定了口服剂型在依从性与差异化竞争上的天然优势, BTK、TYK2/JAK、口服 PROTAC、口服环肽、PDE4 等多技术路线值得持续跟踪。
- CNS: 核心主线是 A β 单抗治疗前移, 跨 BBB 技术放大长期空间。CNS 领域的核心投资主线仍聚焦于 A β 单抗治疗从早期症状人群向临床前 (preclinical AD) 前移, 礼来 Donanemab 相关 III 期数据有望成为打开“早期干预”市场空间的关键催化。既往数据显示, 中低 tau 及更早期人群在疗效与安全性窗口上更具优势。同时, 以罗氏 Trontinemab 为代表的跨血脑屏障 (BBB shuttle) 下一代 A β 疗法, 在更低剂量与更短疗程下实现更强清除效果与更优安全性, 有望进一步抬升 AD 治疗天花板; 系统给药小核酸等新路径作为补充方向, 更多体现为中长期递送方式创新。
- 风险提示: 1) 研发进展不及预期风险; 2) 药品销售不及预期风险; 3) 政策风险; 4) 行业风险; 5) 其他风险。

医药

评级:

增持

相关报告

- 医药《医药行业 2025Q4 公募基金持仓分析》2026.02.04
- 医药《阿斯利康宣布 2030 年前在中国投资 150 亿美元》2026.02.02
- 医药《持续推荐创新药械产业链》2026.02.01
- 医药《V940 五年随访数据披露, mRNA 肿瘤疫苗长期价值验证》2026.01.30
- 医药《支持政策不断, 持续推荐创新药械产业链》2026.01.25

目录

1. 政策、M&A 及重磅数据催化等多重利好驱动积极的投资情绪	3
2. 肿瘤：PD-1/VEGF 双抗确定性持续强化，Pan-RAS 精准治疗进入兑现期 5	
3. 减重代谢：关注自费市场扩容，小核酸推动治疗范式升级.....	7
4. 自免：MNC 大单品集中度风险凸显，2026 年 POC 数据读出带来结构性 机会.....	9
5. CNS：阿尔兹海默症或迎产业拐点，皮下给药小核酸打开新窗口	12
6. 风险提示.....	15

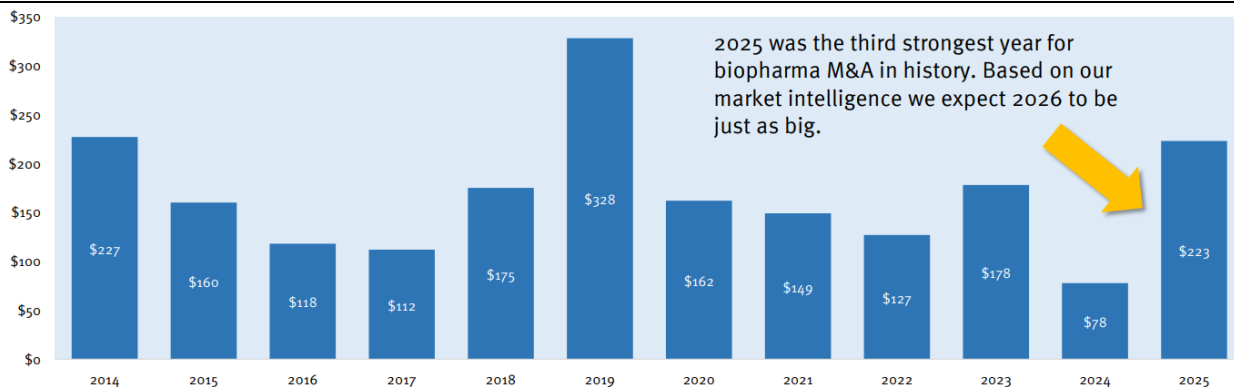
1. 政策、M&A 及重磅数据催化等多重利好驱动积极的投资情绪

受益于政策风险落地、M&A 交易和重磅数据催化等多重积极因素，美股生物科技指数（XBI）和制药指数（DRG）在 2025 年四季度创新高。投资人对于 2026 年创新药投资的情绪非常积极。

政策方面，MFN 药品定价风险落地，具体来说有两个主要积极点（1）影响范围非常有限，仅限 Medicaid 和直销渠道；（2）药企获得 3 年关税豁免。具体在 GLP-1 的谈判上面，市场更是明确解读为利好，主要原因是 Medicare 覆盖减肥药带来的积极影响（从无到有）将明显大于短期降价对于糖尿病市场的冲击（而且糖尿病市场 GLP-1 渗透率仍有显著的提升空间）。药品监管层面，FDA 鼓励创新药优先审评审批的改革逻辑凸显，持续发出国家优先审评券（CNPV），大幅将原来标准审评/优先审评的 10/6 个月缩短至 1-2 个月。目前 FDA 已经发出 18 张 CNPV 券，将显著缩短 First in class 和 Best in class 的品种上市时间，其中包括 1 款来自中国的创新药即科伦博泰的 Sac-TMT（Trop-2 ADC）。

2025 年见证了生物制药领域 M&A 交易总额创下历史第三高的记录，合计交易规模超过 2200 亿美金。代表性交易包括（1）JNJ 以 146 亿美金对价收购 Intra-cellular；（2）诺华以 120 亿美金对价收购 Avidity；（3）辉瑞以 100 亿美金对价收购 Metsera；（5）默沙东分别以 100 亿美金、92 亿美金对价收购 Verona、Cidara；（6）Sanofi 以 91 亿美金对价收购 Blueprint；（7）Genmab 以 80 亿美金收购 Merus。上述 8 项交易中 3 项在 2025 年四季度公告。

图 1: 2025 年生物制药领域的并购交易总额创下历史第三高的纪录（单位：10 亿美金）



资料来源：Stifel，国泰海通证券研究

从 JPM 大会前后两周的 BD 动向看，MNC 药企交易活跃，共完成 12 笔交易，其中 7 笔来自中国资产。交易布局已明显超越传统实体瘤领域，中国创新药在 CNS、核药及 AI 制药等前沿方向的全球吸引力正在加速显现。

表1: 2026 年 JPM 大会前后 (1.1-1.14) MNC 药企 BD 交易复盘

公告日期	买方	卖方	交易类型	交易资产	Upfront/M&A 价格	里程碑	销售分成
2026/1/1	AbbVie	泽璟制药	License option	ZG006 (DLL3 TCE、中国 3 期)	\$160m (包括近期付款)	~\$1.075bn	高个位数~中双位数
2026/1/4	Servier	英矽智能	平台	AI 研发平台	\$31m (包括近期付款)		
2026/1/5	Sanofi	华深智药	License+平台	多个自免双抗项目 (临床前)	\$160m (包括近期付款)	~\$2.4bn	高至双位数
2026/1/6	Roche	Earendil Labs Structure Therapeutics	专利许可	CT-996 (口服 GLP-1、全球 2 期) 的相关专利	\$100m	—	低个位数
2026/1/6	勃林格殷格翰	Variant Bio	License+平台	AI-powered Inference platform	>\$120m (包括里程碑)		
2026/1/7	Lilly	Ventyx Biosciences	M&A	VTX2735 (口服 NLRP3、全球 2 期) VTX3232 (口服 NLRP3、全球 2 期) 等	~\$1.2bn	—	—
2026/1/8	GSK	Noetik	License	OCTO-VC 虚拟细胞基础模型	\$50m (包括近期付款)	—	基于订阅的模式, 需支付年度许可费
2026/1/9	Roche	宜联生物	License	YL201 (B7H3 ADC、全球 1/2 期)	\$570m (包括近期付款)	未披露	未披露
2026/1/12	AbbVie	荣昌生物	License	RC148 (PD-1/VEGF 双抗、中国 2 期)	\$650m	~\$4.95bn	双位数
2026/1/12	Novartis	赛神医药	License	A β 单抗 (采用 BBB shuttle 技术、临床前)	\$165m	~\$1.5bn	未披露
2026/1/12	Novartis	中晟全肽	License	RLT 肽类项目 (早期)	\$50m	未披露	未披露
2026/1/14	AstraZeneca	Modella AI	M&A	生成式和智能体 AI 平台	未披露	—	—

数据来源: 各公司官网, 国泰海通证券研究

2. 肿瘤：PD-1/VEGF 双抗确定性持续强化，Pan-RAS 精准治疗进入兑现期

PD-1/VEGF 双抗的临床与产业确定性正在持续强化。BMS/BioNTech、Summit、辉瑞等 3 家公司已围绕 NSCLC、SCLC、CRC、TNBC 等多个高价值适应症同步开展合计 11 项全球 3 期试验。与此同时，艾伯维近期通过重磅引进荣昌生物的 RC148 切入 PD-1/VEGF 双抗赛道，产业端对于该机制的认可进一步升级。

从催化剂来看，Summit 和康方生物合作的依沃西单抗有望在年底获批上市，成为首个 FDA 批准上市的 PD-1/VEGF 双抗。同时，HARMONI-3 研究有望在年底读出数据，成为首个 1L NSCLC 的全球 3 期数据读出，充分验证 PD-1/VEGF 在 NSCLC 大适应症上的全球潜力。

表2: BMS/BioNTech、Summit、辉瑞分别已开展 7 项、4 项、3 项全球 3 期试验

公司	管线	细分适应症	联合 / 单药	对照组	研发进展	地区	试验名称	NCT 编号	催化剂/里程碑
Summit	依沃西单抗	2L EGFRm NSCLC	联合化疗	化疗	3 期	全球	HARMONI	NCT06396065	2026-11-14, PDUFA
		1L NSCLC	联合化疗	Keytruda 联合化疗	3 期	全球	HARMONI-3	NCT05899608	2026 年 H2, 数据读出 (鳞癌)
		1L PD-L1 TPS > 50% NSCLC	单药	Keytruda	3 期	全球	HARMONI-7	NCT06767514	
		1L 结直肠癌	联合化疗	贝伐珠单抗联合化疗	3 期	全球	HARMONI-GI3	NCT07228832	
BMS/BioNTech	Pumitang	1L NSCLC	联合化疗	Keytruda 联合化疗	2/3 期	全球	ROSETTA Lung-02	NCT06712316	2029 年, 数据读出
		1L PD-L1 high NSCLC	单药	Keytruda	3 期	全球	ROSETTA Lung-202	NCT07361510	
		III 期 NSCLC	单药	Durvalumb	3 期	全球	ROSETTA Lung-201	NCT07361497	
		1L ES-SCLC	联合化疗	PD-L1 单抗联合化疗	3 期	全球	ROSETTA Lung-01	NCT06712355	2028 年, 数据读出
		1L TNBC	联合化疗	化疗	3 期	全球	ROSETTA Breast-01	NCT07173751	2029 年, 数据读出
		1L 结直肠癌	联合化疗	-	2/3 期	全球	ROSETTA CRC-203	NCT07221357	2030 年及以后, 数据读出
		1L GC/GEJ+食管腺癌	联合化疗	O 药联合化疗	2/3 期	全球	ROSETTA Gastric-204	NCT07221149	2030 年及以后, 数据读出
		1L HNSCC			2/3 期 (暂未启动)	全球	ROSETTA HNSCC-205		2030 年及以后, 数据读出
辉瑞	PF-08634404	1L NSCLC	联合化疗	Keytruda 联合化疗	3 期	全球	Symbiotic-Lung-01	NCT07222566	
		1L SCLC	联合化疗	PD-L1 单抗联合化疗	2/3 期	全球	Symbiotic-Lung-04	NCT07226999	
		1L 结直肠癌	联合化疗	贝伐珠单抗联合化疗	3 期	全球	Symbiotic-GI-03	NCT07222800	
		1L 膀胱癌	联合 Nectin-4 ADC		3 期 (暂未启动)	全球			
艾伯维	RC148				tbd	全球			
默沙东	MK-2010				tbd	全球			

数据来源：各公司官网，国泰海通证券研究

从研发策略上来看，各家均在积极探索 PD-1/VEGF 双抗和 ADC 联用的试验。从进度来看 BMS/BioNTech 最为领先，公司已在 2026 年 JPM 大会给出 2026 年内将有 5 项联合 ADC 的数据读出，涉及到 4 款 ADC 管线 (HER2、B7H3、Trop2、HER3)。辉瑞、Summit、艾伯维等 3 家公司也在近期准备推进 ADC 联用试验。辉瑞将率先联合自己的 Nectin-4 ADC，Summit 选择和 GSK 的 B7H3 ADC 联用，而艾伯维预计将与自己的 cMet ADC 联用。

表3: BMS/BioNTech、Summit、辉瑞、AbbVie 的 ADC 联用计划

公司	管线	细分适应症	联合/单药	研发进展	地区	试验名称	NCT 编号	催化剂/里程碑
BMS/BioNTech	Pumitamig	HER2 阳性/低表达/三阴性 BC	HER2 ADC (BNT323)	1/2 期	全球	BNT323-03	NCT06827236	2026 年, 数据读出
		实体瘤	B7H3 ADC (BNT324)	2 期	全球	DB-1311-201	NCT06953089	2026 年, 数据读出
		NSCLC、SCLC	B7H3 ADC (BNT324)	1/2 期	全球	BNT324-01	NCT06892548	2026 年, 数据读出
		TNBC	TROP-2 ADC(BNT325)	1/2 期 (FIH)	全球	DB-1305-O-1001	NCT05438329	2026 年, 数据读出
		2L+ EGFRmNSCLC	HER3 ADC (BNT326)	1/2 期	全球	BNT326-01	NCT07070232	2026 年, 数据读出
辉瑞	PF-08634404	1L 膀胱癌	联合 Nectin-4 ADC	3 期 (暂未启动)	全球			
Summit	依沃西单抗	多种实体瘤	B7H3 ADC (GSK' 227)					2026 年中, 启动
艾伯维	RC148	NSCLC、CRC 等	cMet ADC (ABBV-400)	tbd				

数据来源: 各公司官网, 国泰海通证券研究

在肿瘤精准治疗领域, Revolution 近期关注度持续提升。公司围绕 Pan-RAS 分子 RMC-6236, 在胰腺癌和 NSCLC 等核心适应症中系统推进 1L/2L、单药及联合治疗 (包括化疗、G12D 抑制剂) 的临床开发。其首个 3 期研究 RASolute-302 (2L PDAC) 预计将于 2026 年上半年读出关键数据。与此同时, 我们建议重点关注 RMC-6236 联合 K 药±化疗在 1L NSCLC 中的 PFS/OS 数据, 相关结果有望显著提升该方案在 NSCLC 领域的潜在商业空间。

表4: Revolution Pan-RAS 等管线的临床开发计划

管线	靶点	研发阶段	适应症	试验组	里程碑	启动时间	试验名称	试验编号
Daraxonrasib (RMC-6236)	RAS(ON) multi	3 期准备中	1L NSCLC^	Dara 单药+K 药+化疗	2026 年 H2, 启动			
		3 期	2L NSCLC	Dara 单药	2027 年, 预计数据读出	2025/5/6	RASolute 301	NCT06881784
		3 期	1L PDAC	Dara 单药+/-化疗			RASolute 303	已经启动, 但未披露
		3 期	2L PDAC	Dara 单药	2026 年 H1, 数据读出**	2024/10/16	RASolute 302	NCT06625320
		3 期	辅助治疗 PDAC	Dara 单药		2025/12/15	RASolute 304	NCT07252232
	RMC-6236 RMC-9805	Platform	GI 实体瘤		2025/9/10, 6236 联合化疗 1L PDAC ORR 数据 2026 年 H1, 6236 联合化疗 1L PDAC PFS/OS 数据**		RMC-GI-102	NCT06445062
	Zoldonrasib (RMC-9805)	3 期准备中	1L PDAC^	Zold+化疗	2026 年 H1, 启动		RASolute 305	
			1L PDAC^	Zold+Dara	2026 年 H2, 启动		RASolute 309	
			1L NSCLC^		2026 年 H1, 启动		RASolute 308	
	RMC-6291	RAS(ON) G12C 1 期	G12C 突变肿瘤			2022/9/19	RMC-6291-001	NCT05462717
		RAS(ON) G12C 1 期	G12C 突变肿瘤	RMC-6291 + RMC-6236		2023/11/14	RMC-6291-101	NCT06128551
	RMC-5127	RAS(ON) G12V pre-IND			2026 年 Q1, 进入 1 期临床			
RAS(ON) Inhibitor Combinations	联用	1/2 期	RAS 突变 NSCLC	A: G12C 突变肿瘤: RMC-6291 +/- RMC-6236 + SOC* B: RAS 突变 NSCLC: RMC-6236 + SOC* C: G12D 突变肿瘤 RMC-9805 +/- RMC-6236 + SOC* 2025 年 5 月, B 部分数据首次披露 (仅 ORR) 2026 年, 预计 PFS/OS 数据		2024/1/18	RMC-LUNG-101	NCT06162221

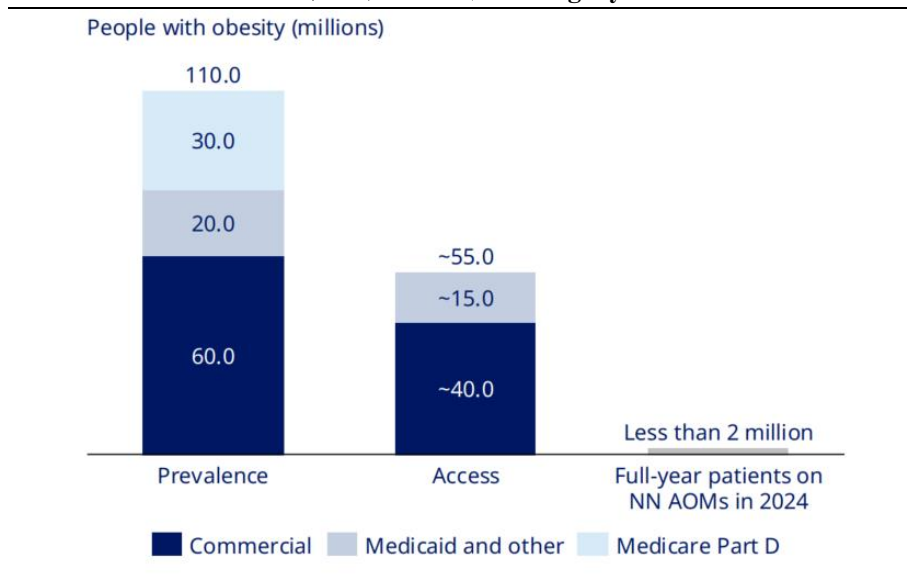
数据来源: Revolution 官网, 国泰海通证券研究, 注: *SOC 为 K 药+/-化疗, **为 2026JPM 给出数据读出/更新指引, ^为 2026JPM 宣布

3. 减重代谢：关注自费市场扩容，小核酸推动治疗范式升级

关注自费渠道带来的 GLP-1 市场扩容机会。当前美国传统支付体系对 GLP-1 类药物的肥胖适应症存在明显覆盖限制。根据公开资料，Medicare 不报销仅用于减重的 GLP-1 药物，而只覆盖用于糖尿病及其他获批适应症的情况。同时，大多数州的 Medicaid 计划也没有涵盖 GLP-1 减重用途，只有少数州提供有限覆盖，而且往往需要 prior authorization。而目前的主要渠道商保实际上对于 GLP-1 的覆盖非常不均衡。

就商保渠道而言，礼来和诺和诺德在近期 JPM 会议都明确指出当前几个显著的问题，（1）覆盖率不高：目前拥有商业保险的人群中，不到 60% 的人群被覆盖；（2）可及性差：保险公司普遍通过事前授权、使用条件限制等方式对肥胖治疗药物的可及性加以管控，导致大量符合医学标准的患者并不能仅因肥胖状态或持有保险而轻易获得相关药物；（3）自付额高：有的患者年自付额高达 5000 美金，和自费一年的费用差不多。在这种背景下，大量患者由于无法获得保险报销，不得不承担现金支付，这直接形成了 GLP-1 自费渠道的商业化机会。

图2：美国约 5500 万肥胖患者的保险覆盖 Wegovy



资料来源：诺和诺德官网，国泰海通证券研究

在美国 GLP-1 自费市场中，礼来和诺和诺德采取了显著不同的直销(DTC)路径。礼来以 LillyDirect 为核心，构建封闭式、自营的直达患者体系，通过 vial 剂型与阶梯式自费定价，将处方、支付与配送高度内化。而诺和诺德则以 NovoCare 为起点，更强调多渠道铺开，通过直配、零售药房及第三方平台协同，快速扩大 Wegovy 在自费人群中的可及性。具体来看，礼来最早在 2024 年 1 月推出公司的直销平台 LillyDirect，随后陆续一年半左右的时间上线了所有版本 Zepbound vials 剂型，并且仅限公司的直销平台邮寄。价格方面经过两次调整（不考虑政府谈判），最新价格\$449/月（以高剂量算）显著高于诺和诺德价格和 TrumpRx 价格。诺和诺德在 2025 年 3 月推出 NovoCare Pharmacy 直销平台，上线 Wegovy，随后很快通过零售药房、telehealth 供应商迅速扩大自费患者和处方医生数量。相较于礼来另一个显著的区别在于，诺和诺德在 2025 年 8 月在直销平台上线 Ozempic。

整体来看，礼来更像是在搭建一个长期使用的直销平台，把处方、支付和配

送都集中在自己体系内；而诺和诺德则是先把自费价格降到患者能接受的水平，再通过直配、药房和第三方平台，把 Wegovy 尽快铺给更多自费人群。

表5: 礼来与诺和诺德 GLP-1 直销（DTC）及自费定价演进情况

时间	公司	影响品种	价格变化情况	重要程度判断	获得渠道
2024 年 1 月 4 日	礼来		(1) 正式推出 LillyDirect 直销平台	重要	
2024 年 8 月 27 日	礼来	Zepbound vials (减重)	(1) LillyDirect 上线 Zepbound vials, 包括 2.5、5mg 两个剂量, 定价\$399/月、\$549/月	重要, 首次上线官方直销平台	(1) LillyDirect: 邮寄
2025 年 2 月 25 日	礼来	Zepbound vials (减重)	(1) LillyDirect 上线 7.5、10mg 两个剂量, 定价\$499/月 (2.5、5mg 降至\$349/月、\$499/月)	重要, 首次降价	(1) LillyDirect: 邮寄
2025 年 3 月 5 日	诺和诺德	Wegovy (减重)	(1) 推出 NovoCare Pharmacy 直销平台, Wegovy 定价\$499/月	重要, 推出官方 cash-pay 平台	(1) NovoCare® Pharmacy: 邮寄
2025 年 3 月 24 日	诺和诺德	Wegovy (减重)	(1) 扩大 Wegovy Savings Offer, 覆盖更多现金支付患者	重要, 覆盖更多自费患者	(1) 零售药房: wegovy.com 登记, 获得 savings card
2025 年 4 月 29 日	诺和诺德	Wegovy (减重)	(1) 与多家 telehealth 组织合作	重要, 扩大处方医生数量	(1) 部分 telehealth 合作供应商, 包括 Hims & Hers Health, Inc., LifeMD, and Ro
2025 年 5 月 22 日	诺和诺德	Wegovy (减重)	(1) 首月定价\$199, 之后\$499/月, 有效期至 2025 年 6 月 30 日		
2025 年 6 月 16 日	礼来	Zepbound vials (减重)	(1) LillyDirect 可以提供所有剂量, 定价\$499/月 (2.5mg 起始剂量为\$349/月)		(1) LillyDirect: 邮寄
2025 年 8 月 18 日	诺和诺德	Wegovy (减重) Ozempic (降糖)	(1) NovoCare Pharmacy 首次上线 Ozempic, 定价\$499/月 (2) GoodRx 合作: Ozempic 和 Wegovy 定价\$499/月	重要, 首次覆盖 Ozempic	(1) NovoCare Pharmacy: 邮寄 (2) Ozempic.com、NovoCare.com 登记 (3) GoodRx 合作: 7 万+药房
2025 年 10 月 29 日	礼来	Zepbound vials (减重)	(1) 可以在 Walmart 线下取药	重要, 接入线下取药点	(1) Walmart 药店: 仍然需要通过 LillyDirect
2025 年 11 月 6 日	诺和诺德	Wegovy (减重) Ozempic (降糖) 口服 Wegovy (减重)	(1) Ozempic 和 Wegovy 的价格从\$1000/1350/月统一下调至\$350/月 (2) 口服 Wegovy 若获批, 起始剂量定价\$150/月		(1) TrumpRx
2025 年 11 月 6 日	礼来	Zepbound (减重) Orforglipron (减重)	(1) Zepbound 和 Orforglipron (若获批) 的价格从\$1086/月统一下调至\$346/月 (2) Orforglipron (若获批), 起始剂量定价\$150/月		(1) TrumpRx
2025 年 11 月 17 日	诺和诺德	Wegovy (减重) Ozempic (降糖)	(1) 定价从\$499/月下调至\$349/月, 2025 年 11 月 17 日生效 (2) 并推出新客低剂量 (0.25、0.5 mg) \$199/月的阶段性 offer, 2025 年 11 月 17 日~2026 年 3 月 31 日生效	重要, 首次调整价格	(1) 7 万+零售药房: 患者自己拿处方去 wegovy.com 和 ozempic.com 登记, 获得 savings card (2) NovoCare Pharmacy 直配: 医生直接把电子处方发到 NovoCare Pharmacy, 邮寄或 CVS 零售点 pickup (3) 部分 telehealth 合作供应商, 包括 Costco, GoodRx, WeightWatchers, Ro, LifeMD, and eMed
2025 年 12 月 1 日	礼来	Zepbound vials (减重)	(1) 2.5mg、5mg 下调至\$299/月、\$399/月, 7.5mg 及以上下调至\$449/月	重要, 二次降价	
2026 年 1 月 5 日	诺和诺德	口服 Wegovy (减重)	(1) 1.5、4、9、25mg 分别定价 \$149/199/299/299/月		(1) GoodRx 合作的 7 万+药房: 通过 GoodRx 平台的医生获得处方

数据来源: 礼来官网, 诺和诺德官网, 国泰海通证券研究

小核酸药物有望推动减重治疗范式升级。近期小核酸减重管线的数据显示, 小核酸联用 GLP-1 在减重幅度、减重质量、以及安全性多维度展现了非常有竞争力的数据。具体来看, ARO-INHBE 联用替尔泊肽相较单用替尔泊肽更显著降低体重~2 倍 (9.4% vs 4.8%)、总脂肪/内脏脂肪/肝脏脂肪~3 倍、以及保留肌肉/增肌。ARO-INHBE 单药 24 周可显著降低内脏脂肪 13.5%。ARO-ALK7 单药 8 周可显著降低内脏脂肪 13.6%。整体安全性良好。

图3: 小核酸减重管线 (INHBE、ALK7) 数据对比

公司 管线 靶点 适应症/人群 给药方案 给药剂量 给药频率 周期 样本量 暴露时间 脱靶反应	Arrowhead														Wave		
	ARO-INHBE INHBE							ARO-ALK7 ALK7							WVE-007 INHBE		
	obesity+T2DM							obesity							obesity-T2DM		
	ARO-INHBE+Tirzepatide	ARO-INHBE+Tirzepatide	Tirzepatide+安慰剂	Tirzepatide	ARO-INHBE	安慰剂	ARO-INHBE	安慰剂	ARO-ALK7	安慰剂	ARO-ALK7	安慰剂	WVE-007	安慰剂	Semaglutide		
	2doses	2doses	—	—	1针	—	2针	—	1针	1针	1针	1针	—	—	—	—	—
	400mg + TZP 5mg	200mg + TZP 5mg	TZP 5mg	TZP 15mg	400mg	—	400mg	—	200mg	100mg	30mg	10mg	—	240mg	—	—	—
	16周 (体重数据)	12周 (MRI数据)	—	52周	16周	—	24周	—	8周	8周	8周	8周	—	12周	—	12周	—
	4	8	5	3期亚组	4	7	7	12	4	4	4	4	8	24	8	2期研究	—
	2026-1-6 call														2025-12-08 call		
	涨11%														涨147%		
	总体重变化	-9.40%	-5.40%	-4.8%	-13.9%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.9%*	—	-3.8%*
	总脂肪变化	-15.4%	-8.2%	-5.3%	未披露	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-4.5%	-0.5%	-4.2%
	内脏脂肪变化	-23.2%	-19.2%	-7.4%	-24.0%	-9.9%	0.0%	-13.5%	2.1%	-13.6%	-12.2%	-5.9%	-5.7%	0.5%	-9.4%	-0.2%	-5.7%
	肝脏脂肪变化	-76.7%	-47.5%	-20.0%	-39.6%	-37.8%	7%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	肌肉变化	—	—	—	—	3.6%	1.6%	—	—	—	—	—	—	—	3.2%	2.30%	-3.5%
	SAE	绝对对数AE都是轻度的														0	0
	TEAE导致研究	1例肢体水肿, 但与研究用药无关														0	0
	或用药中止	无														0	0
	GI AE	联用和单药可比														—	—

资料来源: Arrowhead 官网, Wave 官网, 国泰海通证券研究

4. 自免：MNC 大单品集中度风险凸显，2026 年 POC 数据读出带来结构性机会

MNC 药企自免大单品集中风险凸显。艾伯维、赛诺菲、强生、罗氏等 MNC 在自免领域布局重磅管线，以艾伯维、赛诺菲为代表 MNC 自免单品营收占比较高，存在“专利悬崖”下营收下滑的风险。艾伯维核心管线阿达木单抗、乌帕替尼与利生奇珠单抗 2025 年前三季度营收合计超 200 亿美金，营收占比接近 50%；赛诺菲大单品度普利尤单抗销售额体量较大，前三季度单产品销售占比接近 36%，虽然专利到期时间较晚，但也成为未来潜在风险点。

表6: MNC 药企的自免大单品销售额及收入占比情况（单位：亿美金）

MNC	2025Q1-3 营收	核心自免品种	商品名	靶点与机制	分子形式	核心自免适应症	单品种 2025Q1-3 销售额	核心自免品种占比营收
艾伯维	445(+8%)	阿达木单抗	Humira	TNF- α	单抗	类风湿关节炎、强直性脊柱炎、IBD 等	32(-55%)	7.40%
		乌帕替尼	Rinvoq	JAK1	小分子	特应性皮炎、类风湿关节炎、IBD 等	59(+43%)	13.30%
		利生奇珠单抗	Skyrizi	IL-23p19	单抗	银屑病、IBD 等	126(+58%)	28.20%
赛诺菲	377(+6%)	度普利尤单抗	Dupixent	IL-4R α	单抗	特应性皮炎、哮喘、COPD 等	134(+19%)	35.50%
		沙利鲁单抗	Kevzara	IL-6R	单抗	类风湿关节炎、风湿性多肌痛等	4(+26%)	1.20%
强生制药	696(+5%)	英夫利西单抗	Remicade	TNF- α	单抗	类风湿关节炎、强直性脊柱炎、IBD 等	14(+12%)	2.00%
		戈利木单抗	Simponi	TNF- α	单抗	类风湿关节炎、强直性脊柱炎、IBD 等	20(+27%)	2.90%
		乌司奴单抗	Stelara	IL-12p40	单抗	银屑病、IBD 等	48(-40%)	7.00%
		古塞奇尤单抗	Tremfya	IL-23p19	单抗	银屑病、IBD 等	36(+31%)	5.10%
诺华	412(+11%)	司库奇尤单抗	Cosentyx	IL-17A	单抗	银屑病、强直性脊柱炎、化脓性汗腺炎等	49(+79%)	11.80%
		奥法妥木单抗	Kesimpta	CD20	单抗	多发性硬化	32(+41%)	7.80%
罗氏	549(+7%)	利妥昔单抗	MabThera	CD20	单抗	类风湿关节炎、ITP 等	11(-4%)	2.00%
		奥瑞利珠单抗	Ocrevus	CD20	单抗	多发性硬化	62(+7%)	11.30%
		托珠单抗	Actemra	IL-6R	单抗	类风湿关节炎、动脉炎等	23(+2%)	4.10%
		奥马珠单抗	Xolair	IgE	单抗	荨麻疹、鼻窦炎、哮喘等	27(+34%)	4.90%

数据来源：各公司官网，国泰海通证券研究

B 细胞耗竭疗法与非 TCE 双抗有望迭代一代单抗产品，2026 年进入密集的 POC 数据读出阶段。海内外多家企业已在二代双抗领域进行深度布局，但仍处于早期概念验证阶段；我们预期未来若有重磅数据披露，将催生该领域的 BD 风口。重点关注赛诺菲 IL13/TSPL 双抗与辉瑞两款三抗 2026 年针对特应性皮炎的数据读出。国内企业重点关注康诺亚、荃信生物等。康诺亚在自免二代双抗领域管线进度领先，分别有一款 IL13/TSPL 双抗与 CD3/BCMA 双抗进入 II 期临床，2026 年有望披露 II 期临床数据，其中 CD3/BCMA 双抗有望进入 NDA 申报阶段；荃信生物深耕非 TCE 自免双抗，临床前已储备多条管线，其中一款已授权罗氏，平台价值得到 MNC 背书。

表7: 下一代双抗/多抗产品有望迭代一代单抗注射剂, 催生下一轮自免 BD 风口

技术路径	企业总部	管线	公司	靶点	技术形式	核心适应症	临床阶段	里程碑/催化剂
非 TCE	海外	PF-07264660	辉瑞制药	IL-4/IL-13/IL-33	三抗	成人特应性皮炎	II 期	PCD 时间预估 2026Q4 数据读出
		PF-07275315	辉瑞制药	IL4/IL13/TSLP	三抗	成人特应性皮炎	II 期	PCD 时间预估 2026Q4 数据读出
		Lunsekinig	Sanofi	IL13/TSLP	双抗	哮喘	II 期	2026 年有望读出 II 期数据并启动 III 期
						特应性皮炎	II 期	PCD 时间预估即将读出
		Galvokimig	UCB	IL13/IL17A/IL17F	三抗	成人特应性皮炎	I/II 期	2025 EADV 读 I/II 期数据, 试验组 EASI75 达 64.9%, 安慰剂 12.3%, 疗效优于 dupi
						化脓性汗腺炎	II 期	PCD 时间预估 2026Q4 数据读出
	中国	Tibulizumab	礼来	IL17/BAFF	双抗	弥漫性皮肤系统性硬化	II 期	
						系统性硬化症		
		Brivekimig	Sanofi	TNF- α /OX40L	双抗	化脓性汗腺炎	IIa 期	2025 EADV 公布早期数据
						化脓性汗腺炎	IIb 期	2027 年有望读出 IIb 期数据
		CM512	康诺亚	IL13/TSLP	双抗	特应性皮炎	II 期	PCD 时间预估 2026Q3 数据读出
						CRSwNP	II 期	PCD 时间预估 2026Q3 数据读出
B 细胞耗竭疗法	海外	QX027N	圣信生物	TSLP/IL13	双抗	特应性皮炎	I 期	
		ZL-1503	再鼎医药	IL13/IL31R	双抗	特应性皮炎	I 期	预计 2026H2 早期临床数据读出
		莫妥珠单抗	罗氏	CD3/CD20	双抗	狼疮肾炎, 系统性红斑狼疮	II 期	
		贝林妥欧单抗皮下注射	安进	CD3/CD19	双抗	狼疮肾炎, 系统性红斑狼疮	II 期	
		莫妥珠单抗皮下	罗氏	CD3/CD20	双抗	系统性红斑狼疮	I 期	2025-06-11 披露早期数据, 关注进一步数据读出节奏
		RO7507062	罗氏	CD3/CD19	双抗	系统性红斑狼疮	I 期	
	中国	PIT565	诺华制药	CD3/CD2/CD19	三抗	系统性红斑狼疮	I 期	
		Gamgertamig	康诺亚	CD3/BCMA	双抗	AL 型淀粉样变性	II 期	预计 2026 年中读 II 期数据, 下半年递交 NDA
						POEMS 综合征	II 期	
		伟利妥米单抗	智翔金泰	CD3/BCMA	双抗	系统性红斑狼疮	I/II 期	
		SCTB35	神州细胞	CD3/CD20	双抗	系统性红斑狼疮	I/II 期	

数据来源: 各公司官网, Insight 数据库, 国泰海通证券研究

自免类疾病一般较难根治, 口服类药物有望提升患者长期用药的依从性, 相较注射剂产品拥有差异化竞争优势。口服领域演化出了多条技术路径, 包括 BTK 抑制剂、口服 PROTAC、JAK 抑制剂/TYK2 抑制剂、口服环肽、PDE4 抑制剂等。国内企业重点关注益方生物、和美药业、海思科等。益方生物的 TYK2 抑制剂目前在银屑病领域拥有全球 BID 潜力, 同时积极布局 IBD/SLE 等难治自免适应症; 和美药业的 PDE4 抑制剂莫米斯特针对银屑病国内已获批上市, 在溃疡性结肠炎适应症中展现出了较单抗更好的临床疗效; Kymera 的 STAT6 PROTAC 已初步展现出不亚于度普利尤单抗的早期临床数据, 有望催生下一个 BD 风口, 重点关注国内已有相关 PROTAC 平台布局的企业 (甘李药业、益方生物、海思科等)。

表8: 口服是自免赛道另一个差异化竞争领域，多条技术路径值得关注

技术路径	企业总部	管线	公司	靶点	技术形式	核心适应症	临床阶段	里程碑/催化剂
口服 PROTAC	海外	KT-621	Kymera	STAT6	PROTAC	特应性皮炎 嗜酸性粒细胞哮喘	II 期	IIb 数据预计 2027 年中读出
		KT-474	Kymera	IRAK4	PROTAC	特应性皮炎 化脓性汗腺炎	II 期	2026Q1 哮喘适应症进入 III 期临床
		BIIB142	渤健制药	IRAK4	PROTAC	自身免疫类疾病	I 期	
	中国	BGB-45035	百济神州	IRAK4	PROTAC	类风湿关节炎	II 期	PCD 时间预计 2026Q4 数据读出
口服 TYK2 抑制剂	海外	Deucravacitinib 氘可来昔替尼	BMS	TYK2	小分子	SLE	III 期	预计 2026 读出
						干燥综合征	III 期	预计 2027 读出
		Zasocitinib	武田	TYK2	小分子	斑块状银屑病	III 期	预计 2026 NDA, 2027 年获批上市
						克罗恩病	II 期	PCD 预计 2026 IIb 读出
	中国	ICP-488	诺诚健华	TYK2	小分子	溃疡性结肠炎	II 期	PCD 预计 2026 IIb 读出
						中重度斑块状银屑病	III 期	PCD 预计 2026 下半年读出 III 期数据
		HS-10374	翰森制药	TYK2	小分子	斑块状银屑病	III 期	
						银屑病关节炎	II 期	
		ESK-001	Alumis/海思科(转让)	TYK2	小分子	斑块状银屑病	III 期	PCD 预计 2026 年读出数据
		ICP-332	诺诚健华	TYK2/JAK1	小分子	SLE	II 期	PCD 预计 2026 年读出数据
口服环肽	海外	伊可白滞素	强生制药	IL-23R	环状多肽	特应性皮炎	III 期	2025.07 已申报 NDA
						斑块状银屑病	III 期	
						系统性红斑狼疮	II 期	

数据来源：各公司官网，Insight 数据库，国泰海通证券研究

5. CNS: 阿尔兹海默症或迎产业拐点，皮下给药小核酸打开新窗口

礼来的 A β 单抗 Donanemab 治疗临床前 AD (preclinical AD) 的 3 期试验数据有望在 2026 年读出，进而打开一个巨大的 AD 市场。此前的试验数据显示，无论是礼来的 Donanemab 还是卫材/Biogen 的 Lecanemab 亚组分析均表明中低 tau 亚组中延缓疾病进展的效果更明显。因此我们看好 Donanemab 在临床前 AD 中的疗效。此外，临床前 AD 患者的 A β 斑块负担更低，理论上 ARIA (淀粉样蛋白相关影像异常，包括水肿、出血) 的发生率和严重程度也更低。

礼来的 A β 单抗 Donanemab 治疗临床前 AD (preclinical AD) 的 3 期试验数据有望于 2026 年读出，有望进一步打开规模可观的阿尔茨海默病早期干预市场。既往研究显示，无论是 Donanemab，还是卫材/Biogen 的 Lecanemab，其亚组分析均提示在中低 tau 人群中对疾病进展的延缓效果更为显著，支持“越早干预、疗效越好”的生物学逻辑。因此，我们看好 Donanemab 在临床前 AD 人群中的潜在疗效表现。与此同时，临床前 AD 患者的 A β 斑块负担相对较低，从机制上看，其 ARIA (淀粉样蛋白相关影像异常，包括水肿和出血) 发生率及严重程度亦有望低于症状期人群，安全性窗口可能更优。

表9: 海外 A β 相关管线布局情况

管线	公司	靶点	类型	适应症	试验名称	试验阶段	催化剂/里程碑
多奈单抗 Donanemab	礼来	pE3A β	单抗	早期症状 AD	TRAILBLAZER-ALZ 2	III 期	数据读出，中美均获批；采用“有限疗程”方案
				preclinical AD	TRAILBLAZER-ALZ 3	III 期	市场预期 2026 年有中期数据分析
				早期症状 AD	TRAILBLAZER-ALZ 4	III 期	
				早期症状 AD (更多合并症)	TRAILBLAZER-ALZ 5	III 期	
				早期症状 AD	TRAILBLAZER-ALZ 6	III 期	
				早期症状 AD	Clarity AD	III 期	数据已读出，中国获批
仑卡奈单抗 Lecanemab	Biogen 卫材药业	A β	单抗	早期症状 AD	BAN2401-G000-201	III 期	数据已读出，美国获批
				早期症状 AD	AHEAD 3-45	III 期	
				preclinical AD	DIAN - TU - 001	III 期	
				显性遗传性 AD	NexGen	III 期	
阿杜那单抗 Aducanumab	Neurimmune Biogen	A β	单抗	早期症状 AD	EMERGE	III 期	因安全性问题终止试验，Biogen 于 2024 年初主动宣布，将全面停止该药物的开发、销售和商业化
Remternetug Remternetug 皮下注射	礼来制药	pE3A β	单抗	早期症状 AD	TRAILRUNNER-ALZ 1	III 期	
Sabirnetug	默沙东	A β	单抗	早期症状 AD	ALTITUDE-AD	II 期	
PMN 310	ProMIS Neurosciences	A β	单抗				
PRX012	Prothena Corp	A β	单抗				
Trontinemab	罗氏制药	A β /TIR1	双抗	早期症状 AD	TRONTIER 1	III 期	
				早期症状 AD	TRONTIER 2	III 期	
				轻中度 AD		I/II 期	早期数据披露，疗效优异安全性良好
				preclinical AD		III 期	计划 2026 年启动 III 期
ALIA-1758	艾伯维	pE3A β /TIR	双抗	健康人		I 期	
PRX123	Prothena Corp	A β /Tau	双抗				
ADP037-ABC	Alector	A β /TIR1	双抗				
抗 TREM2/A β 双抗(罗氏)	罗氏制药	A β /TREM2	双抗				
BAN2803	BioArctic BMS	pE3A β /TIR	双抗				
BEY2153	BeyondBio	Tau/A β	小分子	早期症状 AD		II 期	
Contraloid Acetate	Priavoid	A β	小分子	早期症状 AD	PRImus-AD	II 期	
s-603	Amyloid Solution	A β /Tau	小分子	健康人		I 期	
GAL-101(oral)	Galimedix	A β	小分子				
ACI-24	AC Immune 武田	A β	治疗性疫苗	唐氏综合征 AD	ABATE	I/II 期	
ALZN-002	Alzamend Neuro	A β	治疗性疫苗	早期症状 AD	ALZN002-01	I/II 期	
AV-1959R+1980R	Nuravax	A β +tau	治疗性疫苗	健康人		I 期	
AV-1959R	Nuravax	A β	治疗性疫苗				
AV-1959D	Nuravax	A β	治疗性疫苗				

数据来源：各公司官网，Insight 数据库，国泰海通证券研究

表10: 国内 A β 相关管线布局情况

管线	公司	靶点	产品类型	适应症	试验名称	试验阶段	催化剂/里程碑
SHR-1707	恒瑞医药	A β	单抗	早期症状 AD	SHR-1707-201	II 期	
CM383	康诺亚	A β	单抗	早期症状 AD		I 期	
CM559	康诺亚	A β	单抗	健康人	CM559-109001	I 期	
AA001	北京智源鸿晟生物	A β	单抗				
9MW4611	迈威生物	A β	单抗				
抗 pE3A β 抗体(齐鲁制药)	齐鲁制药	pE3A β	单抗				
抗 pE3A β 抗体(恒瑞医药)	恒瑞医药	pE3A β	单抗				
抗 pE3A β 抗体(加科思)	加科思	pE3A β	单抗				
AK152	康方生物	A β /TfR1 (推测)	双抗	健康人/AD		I 期	
SNP837	诺华 赛神药业	A β /TfR1 (推测)	双抗				
TML-6	美力龄生医	APOE A β 等	小分子				2025.08 I 期临床试验完成
Protollin	恩华药业	A β	治疗性疫苗	早期症状 AD		I 期	早期试验已完成

数据来源：各公司官网，Insight 数据库，国泰海通证券研究

与此同时，我们认为以罗氏 Trontinemab 为代表的下一代 A β 单抗正通过“跨血脑屏障”机制显著抬升 AD 领域的治疗天花板，从而进一步放大该领域的市场机会。罗氏的 A β /TfR1 双抗 Trontinemab 一端靶向 A β 以清除斑块，另一端靶向血脑屏障上的转铁蛋白受体 (TfR1)，能够主动穿越血脑屏障，相较于单靶的 A β 在机制上更具优势 Trontinemab 在更低的给药剂量下 (3.6mg/kg)、更短的给药周期 (28 周) 内比多奈单抗与仑卡奈单抗实现了更好的淀粉样斑块清除效果；同时，安全性也更佳，ARIA-E/ARIA-H 发生率远低于两个上市的单抗产品。

表11: 罗氏的 Trontinemab 相较竞品带来显著更好的 A β 清除效果和安全性

产品	多奈单抗/Donanemab	仑卡奈单抗/Lecanemab	Trontinemab
公司	礼来制药	渤健制药; 卫材	罗氏制药
靶点	pE3A β	A β	A β TfR1
临床试验名称	TRAILBLAZER-ALZ 2	Clarity AD	-
临床阶段	III 期	III 期	I/II 期
读出时间	2023.07	2022.11	2025.08
适应症	早期症状 AD	早期症状 AD	轻中度 AD
亚组设计	总人群	总人群	
患者人数	860	876	859
给药方案	Donanemab IV 700mg*3+1400mg Q4W	P placebo 10mg/kg Q2W	Trontinemab IV 3.6mg/kg Q4W 1.8mg/kg Q4W P placebo
随访时间	76 周	72 周	28 周
基线数据	基本信息	平均年龄	73
	量表评分	MMSE	22.4
		CDR-SB	4
		淀粉样斑块变化 (Centiloid)	-87
		淀粉样斑块清除<30 CL 比例	76.40%
		淀粉样斑块清除<24 CL 比例	0.30%
		淀粉样斑块清除<11 CL 比例	91%
			65%
			0%
			72%
			47%
			0%
安全性数据	安全性样本量	试验组+安慰剂 组 样本量: 76	试验组+安慰剂 组 样本量: 75
	总体	TRAE	48.10%
		SAE	17.40%
		死亡率	1.90%
		治疗相关死亡率	0.40%
		因不良反应而停止治疗	13.10%
	ARIA	ARIA-E	24.00%
		ARIA-H	19.70%
		ApoE ϵ 4 homozygote	50.30%
	其他典型 AE	头痛	14.00%
		注射部位不良反应	8.70%
		中枢神经系统表面铁质 沉积症	6.80%

数据来源：各公司官网，国泰海通证券研究

在 CNS 领域，小核酸治疗正出现实质性进展。以 Arrowhead 的 ARO-MAPT 为代表，该项目是一款靶向 Tau（MAPT）的 RNAi 小核酸药物，采用皮下给药的系统性递送方式，目标是在不依赖鞘内注射的情况下，实现对中枢 Tau 通路的持续抑制。相较传统 CNS 小核酸以侵入式给药为主的模式，皮下给药在给药便利性、患者依从性及长期用药可行性上具备明显优势。公司预计 2026 年 H2，1/2 期试验数据读出。若后续临床数据验证其在中枢生物标志物 and 安全性上的可行性，皮下给药小核酸有望为阿尔兹海默症等 CNS 疾病打开全新的治疗窗口。

6. 风险提示

- 1) 研发进展不及预期风险、
- 2) 药品销售不及预期风险、
- 3) 政策风险、
- 4) 行业风险、
- 5) 其他风险。

本公司是本报告所述荣昌生物(688331),神州细胞(688520)的做市券商。本报告系本公司分析师根据荣昌生物(688331),神州细胞(688520)公开信息所做的独立判断。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

		评级	说明
投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
		谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
		中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
		减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
		增持	明显强于沪深 300 指数
	行业投资评级	中性	基本与沪深 300 指数持平
		减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰海通证券研究所

地址 上海市黄浦区中山南路 888 号

邮编 200011

电话 (021) 38676666